Клинические рекомендации

Острый синусит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J01** — Острый синусит
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 28.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/313_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определение 4

2.2 Критерии диагноза 4

2.3 Степень тяжести 4

2.4 Классификация 5

3. Диагностика 5

3.1 Осмотр ЛОР-органов 5

3.2 Эндоскопия полости носа и носоглотки 5

3.3 Компьютерная томография околоносовых пазух 6

3.4 Рентгенография околоносовых пазух 6

3.5 Ультразвуковое исследование околоносовых пазух 6

3.6 Общий (клинический) анализ крови 6

3.7 Бактериологическое исследование 6

3.8 Дифференциальная диагностика 7

4. Лечение 8

4.1 Показания к антибактериальной терапии 8

4.2 Дозы стартовой терапии 9

4.3 Парентеральная терапия при тяжёлом течении 10

4.4 Местная и симптоматическая терапия 11

4.5 Хирургическое лечение 12

4.6 Профилактика 12

4.7 Особые случаи 12

5. Показания к госпитализации. Осложнения 12

6. Источник и актуальность **12**
6.1 Исправления по результатам сверки с PDF 13
6.2 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 13
6.3 Шкалы доказательности 13

1. Основные положения

- Диагноз острого синусита у взрослых:

  Обязательные критерии

  1. острое начало заболевания;
  2. **два симптома и более**, из которых обязательно присутствуют заложенность носа и (или) выделения из носа, в том числе стекание слизи по задней стенке глотки (постназальный синдром);
  3. сохранение симптомов **не более 12 недель**.

  Возможные симптомы

  1. боль или ощущение давления в проекции околоносовых пазух на лице;
  2. снижение или потеря обоняния.
- Диагноз острого синусита у детей:

  Обязательные критерии

  1. острое начало заболевания;
  2. **не менее двух** симптомов из перечисленных ниже;
  3. сохранение симптомов **не более 12 недель**.

  Симптомы

  1. заложенность носа;
  2. выделения из носа, в том числе стекание по задней стенке глотки (постназальный синдром);
  3. кашель.
- Системная антибактериальная терапия взрослым показана:
  1. при среднетяжёлом и тяжёлом течении;
  2. при лёгком течении рецидивирующего синусита с сохранением симптомов **5–7 дней и более**;
  3. при лёгком течении на фоне тяжёлой сопутствующей патологии или иммунодефицита.
- При впервые возникшем синусите стартовым препаратом является незащищённый аминопенициллин (амоксициллин). Если заметного эффекта нет **в течение 3 дней**, препарат заменяют.
- Местная терапия:
  1. промывание полости носа солевыми растворами;
  2. сосудосуживающие капли **не более 5–7 дней**;
  3. интраназальные глюкокортикостероиды пациентам **старше 12 лет**.
- Показания к экстренной госпитализации:
  1. тяжёлое течение;
  2. орбитальные или внутричерепные осложнения;
  3. отсутствие улучшения на фоне системной антибактериальной терапии **в течение 3–5 дней**;
  4. ухудшение состояния в любой момент.

2. Клиническая картина и классификация

раздел 1 текста КР

2.1 Определение

Острый синусит представляет собой острое воспаление слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух продолжительностью **менее 12 недель**, проявляющееся не менее чем двумя симптомами (перечислены в критериях диагноза ниже). Часть симптомов может быть заменена данными риноскопии, эндоскопии или компьютерной томографии (КТ).

Синусит считается рецидивирующим при 4 эпизодах и более за последний год, если между эпизодами имеются периоды не менее 8 недель без симптомов и без лечения.

Острый поствирусный синусит диагностируется при сохранении симптомов более 10 дней после острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) и отсутствии признаков бактериального синусита. Как правило, он протекает легче и разрешается без антибактериальной терапии.

2.2 Критерии диагноза

У взрослых:

Обязательные критерии

1. острое начало заболевания;
2. **два симптома и более**, из которых обязательно присутствуют заложенность носа и (или) выделения из носа, в том числе стекание слизи по задней стенке глотки (постназальный синдром);
3. сохранение симптомов **не более 12 недель**.

Возможные симптомы

1. боль или ощущение давления в проекции околоносовых пазух на лице;
2. снижение или потеря обоняния.

У детей:

Обязательные критерии

1. острое начало заболевания;
2. **не менее двух** симптомов из перечисленных ниже;
3. сохранение симптомов **не более 12 недель**.

Симптомы

1. заложенность носа;
2. выделения из носа, в том числе стекание по задней стенке глотки (постназальный синдром);
3. кашель.

Болевой синдром может отсутствовать. При верхнечелюстном синусите боль локализуется в проекции пазухи, реже в области переносицы и надбровья, и может иррадиировать в верхние зубы. Для сфеноидита характерна боль в центре головы и в затылочной области (каскообразная боль).

У детей синусит часто сочетается с гипертрофией и хроническим воспалением глоточной миндалины и может проявляться упорным кашлем или выраженным затруднением носового дыхания.

2.3 Степень тяжести

Форма	Признаки
Лёгкая	Лихорадка отсутствует. Умеренные симптомы, не влияющие или незначительно влияющие на качество жизни. Головная боль в проекции околоносовых пазух (ОНП) отсутствует. Осложнений нет
Среднетяжёлая	Выраженные симптомы, умеренно или значительно влияющие на качество жизни. Ощущение тяжести в проекции ОНП при движении или наклоне головы. Осложнение со стороны среднего уха (острый средний отит). Внутричерепные и орбитальные осложнения отсутствуют

Форма	Признаки
Тяжёлая	Выраженные или мучительные симптомы. Болезненность в проекции ОНП, усиливающаяся при движении, наклоне головы, перкуссии. Внутричерепные или орбитальные осложнения

2.4 Классификация

В 90–98% случаев возбудителями синусита являются вирусы, на долю бактериального синусита приходится лишь 2–10%.

По этиологии выделяют вирусный, бактериальный, травматический, грибковый (в виде острого процесса встречается крайне редко) и смешанный синусит. Изолированный бактериальный синусит встречается редко; как правило, имеет место сочетание вирусов или вирусов и бактерий.

По локализации различают гайморит, фронтит, этмоидит и сфеноидит. Поражение всех пазух одной половины носа обозначается как гемисинусит, обеих половин как пансинусит.

---

3. Диагностика

раздел 2 текста КР

3.1 Осмотр ЛОР-органов

Показания

1. всем пациентам при обращении к оториноларингологу и при госпитализации в стационар: общий осмотр и стандартный оториноларингологический осмотр.

Диагностические признаки при риноскопии

1. отделяемое в носовых ходах;
2. гиперемия и отёк слизистой оболочки полости носа;
3. отделяемое в среднем носовом ходе (передняя риноскопия) указывает на возможное поражение лобной и верхнечелюстной пазух, передних и средних клеток решётчатого лабиринта;
4. отделяемое в верхнем носовом ходе (задняя риноскопия) указывает на возможное поражение задних клеток решётчатого лабиринта и клиновидной пазухи.

Отсутствие отделяемого не исключает острого синусита: его может не быть при блоке естественных соустий и высокой вязкости секрета.

3.2 Эндоскопия полости носа и носоглотки

Показания

1. оценка состояния полости носа и носоглотки;
2. дифференциальная диагностика.

В большинстве случаев эндоскопия не информативнее передней и средней риноскопии, но помогает отличить сфеноидит от аденоидита и выявить длительно находящееся инородное тело полости носа.

Диагностические признаки

1. гнойное отделяемое и (или) отёк слизистой оболочки в области остиомеатального комплекса; эти данные подтверждают диагноз.

3.3 Компьютерная томография околоносовых пазух

Показания к спиральной КТ

1. подозрение на внутричерепные или орбитальные осложнения;
2. затяжное тяжёлое течение;
3. сложные диагностические случаи.

Диагностические признаки

1. признаки воспаления в околоносовых пазухах и (или) в области остиомеатального комплекса; они подтверждают диагноз.

КТ является наиболее информативным методом: она показывает характер и распространённость изменений, а также анатомические особенности полости носа и пазух, ведущие к рецидивам, и визуализирует структуры, неразличимые на рентгенограмме.

3.4 Рентгенография околоносовых пазух

Показания

1. среднетяжёлое и тяжёлое течение;
2. сложные диагностические случаи при невозможности выполнить КТ.

Диагностические признаки

1. утолщение слизистой оболочки пазухи;
2. горизонтальный уровень жидкости;
3. тотальное снижение пневматизации пазухи.

Интерпретацию затрудняют наложение окружающих костных структур и гипоплазия пазухи.

Данные рентгенографии и КТ совпадают лишь в 34% случаев, для верхнечелюстной пазухи в 77%.

3.5 Ультразвуковое исследование околоносовых пазух

Показания

1. подозрение на верхнечелюстной или лобный синусит при невозможности выполнить рентгенографию и КТ.

3.6 Общий (клинический) анализ крови

Показания

1. среднетяжёлое и тяжёлое течение.

Диагностические признаки

1. лейкоцитоз с нейтрофилёзом не является специфическим маркером бактериального синусита, однако его нарастание при повторном исследовании учитывают при решении вопроса о системной антибактериальной терапии.

3.7 Бактериологическое исследование

Посев гнойного отделяемого на аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антибиотикам.

Показания

1. среднетяжёлое и тяжёлое течение у пациентов в стационаре;
2. затяжное течение;
3. неэффективность эмпирической антибактериальной терапии.

Забор материала

1. при верхнечелюстном синусите материал получают при пункции пазухи иглой Куликовского с аспирацией содержимого; если его нет, вводят стерильный 0,9% раствор натрия хлорида и аспирируют;
2. посев из носового хода нецелесообразен из-за попадания в материал посторонней микрофлоры.

Иные диагностические исследования не показаны.

3.8 Дифференциальная диагностика

У взрослых острый синусит дифференцируют с обострением хронического риносинусита, аллергическим и хроническими ринитами, у детей также с аденоидитом и инородным телом полости носа.

Заболевание	Общие с острым синуситом признаки	Отличия от острого синусита
Хронический риносинусит	Манифестация и обострения по клиническим проявлениям идентичны острому синуситу	1. назальные симптомы полностью не разрешаются в течение 12 недель даже на фоне лечения: пациенты отмечают улучшение, но не полное исчезновение симптомов; 2. у детей хронический риносинусит встречается значительно реже острого синусита; 3. в этиологии преобладают неинфекционные факторы: генетические аномалии, аллергия, аномалии строения полости носа.
Аллергический ринит	Сходные назальные симптомы: заложенность носа, выделения из носа, кашель вследствие постназального затекания. Аллергический ринит повышает риск острого синусита	1. симптомы повторяются; 2. значительно чаще беспокоят зуд в носу и (или) чихание; 3. характерны глазные симптомы (зуд в глазах, слезотечение), особенно при поллинозе; 4. в основе патогенеза лежит IgE-ассоциированное воспаление слизистой оболочки; 5. диагноз устанавливают по аллергологическому анамнезу, характеру симптомов и результатам специфического аллергологического обследования.

Заболевание	Общие с острым синуситом признаки	Отличия от острого синусита
Аденоидит	Сходные назальные симптомы: заложенность носа, кашель вследствие постназального затекания, реже выделения из носа. У детей младше 10–12 лет воспаление в полости носа и околоносовых пазухах всегда сопровождается реактивным воспалением глоточной миндалины	1. у детей раннего и дошкольного возраста, не перенёсших аденотомию, при жалобах на «острый насморк» граница между острым синуситом и аденоидитом очень условна; 2. в отдельных случаях помогает эндоскопия полости носа и носоглотки: скопление отделяемого в среднем носовом ходе при небольшом его количестве в носоглотке больше характерно для острого синусита; 3. у дошкольников без признаков внутричерепных и орбитальных осложнений и без критериев острого бактериального синусита основным диагнозом целесообразно указывать аденоидит или острый назофарингит.
Инородное тело полости носа	Родители ребёнка могут жаловаться на остро возникшую заложенность носа и (или) гнойные выделения из носа, особенно при инородном теле органического происхождения	1. трудности возникают, когда ребёнок незаметно для родителей вводит в нос органические вещества: кусочки пищи, семена растений, бумагу, поролон; 2. воспалительные изменения, как правило, односторонние, гнойные выделения появляются на фоне полного здоровья без предшествующего эпизода острого респираторного заболевания; 3. инородное тело выявляют при передней риноскопии после анемизации и аспирационного туалета полости носа, в ряде случаев при эндоскопии полости носа и носоглотки.

4. Лечение

раздел 3 текста КР

4.1 Показания к антибактериальной терапии

Взрослым антибактериальная терапия показана:

1. при среднетяжёлом и тяжёлом синусите;
2. при лёгком течении рецидивирующего синусита с сохранением симптомов **5–7 дней и более**;
3. при лёгком течении на фоне тяжёлой сопутствующей патологии (например, сахарного диабета) или иммунодефицита.

О бактериальном синусите свидетельствуют **три признака и более**:

1. гнойные выделения или выделения только из одной половины носа **в течение 3 дней и более**;
2. головная боль или ощущение давления в проекции верхнечелюстных или лобных пазух;
3. температура тела **38,0 °C и выше**;
4. «вторая волна» заболевания;
5. лейкоцитоз **выше 15×10^9/л**.

На бактериальную этиологию указывают также выраженные с самого начала симптомы, сохраняющиеся 3–4 дня и угрожающие развитием орбитальных или внутричерепных осложнений.

Детям антибактериальная терапия показана при признаках бактериального синусита, среднетяжёлом и тяжёлом течении. При лёгком течении антибиотики необходимы при наличии хотя бы одного из условий:

1. орбитальные или внутричерепные осложнения;
2. три признака бактериального синусита и более;
3. иммунодефицит, муковисцидоз, первичная цилиарная дискинезия, некомпенсированный сахарный диабет I типа;
4. 4 эпизода синусита и более за последний год.

При впервые возникшем синусите терапия начинается с незащищённых аминопенициллинов.

При высоком риске устойчивости пневмококка доза амоксициллина увеличивается. При сопутствующих заболеваниях, иммуносупрессии, в возрасте старше 65 лет и при неэффективности ранее назначенного амоксициллина терапия начинается с защищённых аминопенициллинов.

При отсутствии заметного эффекта **в течение 3 дней** препарат заменяют, не дожидаясь окончания курса. У детей эффективность оценивают **через 48–72 часа**.

4.2 Дозы стартовой терапии

Взрослые

Препарат	Доза
Амоксициллин внутрь	500 мг × 3 р/сут — без факторов риска[1] 1000 мг × 3 р/сут — при факторах риска[1]
Амоксициллин + клавулановая кислота внутрь[2]	500/125 мг × 3 р/сут или 875/125 мг × 2 р/сут
Цефуроксим	250–500 мг × 2 р/сут
Цефиксим	400 мг × 1 р/сут
Цефдиторен внутрь	200 мг × 2 р/сут
Цефподоксим внутрь	200 мг × 2 р/сут
Аллергия на β-лактамы	
Кларитромицин внутрь	250–500 мг × 2 р/сут
Левофлоксацин внутрь	500 мг × 1 р/сут
Моксифлоксацин внутрь	400 мг × 1 р/сут
Клиндамицин в/м (в КР со знаком #)	400–900 мг × 3 р/сут, 7–10 дней

[1] Риск устойчивости пневмококка повышают приём антибиотиков в предшествующие 3 месяца, наличие в семье детей дошкольного возраста, посещающих детский сад, и проживание в закрытых учреждениях.

[2] Риск продукции бета-лактамаз (H. influenzae, S. aureus, M. catarrhalis) повышают бронхиальная астма, сахарный диабет, хронический бронхит, иммуносупрессия, возраст старше 65 лет и неэффективность предшествующей терапии амоксициллином.

Продолжительность лечения неосложнённого синусита составляет 7 дней, осложнённого 10–14 дней.

Макролиды являются препаратами резерва и применяются только при IgE-опосредованной непереносимости бета-лактамов. Фторхинолоны допустимы только у взрослых и только при отсутствии других вариантов; детям и подросткам они противопоказаны.

Дети

Препарат	Доза
Амоксициллин внутрь	40–60 мг/кг/сут — без факторов риска[1] 80–90 мг/кг/сут — при факторах риска[1]
Амоксициллин + клавулановая кислота внутрь	45–60 мг/кг/сут в 2–3 приёма
Цефуроксим	30 мг/кг/сут в 2 приёма, не более 500 мг в сутки
Цефиксим	8 мг/кг/сут в 1–2 приёма
Цефдиторен, цефподоксим (старше 12 лет) внутрь	200 мг × 2 р/сут
Аллергия на β-лактамы	
Кларитромицин внутрь	15 мг/кг/сут в 2 приёма, макс. 1000 мг/сут
Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат в/м (стационар, если β-лактамы невозможны)	125–250 мг 2–3 р/сут в зависимости от возраста

Амоксициллин с клавулановой кислотой предпочтителен, если за последние 3 месяца ребёнок получал антибиотики или посещает детский коллектив, а также при неэффективности амоксициллина в течение 48–72 часов. При лёгкой аллергии на пенициллины применяют цефалоспорины III поколения внутрь.

Дозы из расчёта на килограмм массы тела предназначены для детей с массой тела менее 40 кг; при массе 40 кг и более используют дозы для взрослых.

Продолжительность лечения неосложнённого синусита составляет 7–10 дней, при орбитальных и внутричерепных осложнениях или рецидивирующем течении 10–14 дней.

> В тексте КР имеется расхождение: в разделе 3.1 стартовая доза амоксициллина для детей составляет 50–60 мг/кг в сутки в 2–3 приёма, в таблице 5 указано 40–60 мг/кг в сутки (80–90 мг/кг при факторах риска). На сайте приведены данные таблицы.

4.3 Парентеральная терапия при тяжёлом течении

Взрослым при тяжёлом синусите вводятся цефотаксим или цефтриаксон, возможно также внутривенное введение амоксициллина с клавулановой кислотой. При риске анаэробной инфекции применяют клиндамицин в сочетании с цефалоспорином III поколения. При неэффективности стартовой

парентеральной терапии рассматривается назначение цефоперазона с сульбактамом 2–4 г в сутки внутривенно в 2 введения, при резистентных штаммах препаратов резерва с учётом чувствительности.

Детям вводятся ампициллин с сульбактамом 300 мг/кг в сутки в 3–4 введения, цефтриаксон 75 мг/кг в сутки в 2 введения или цефотаксим 100–200 мг/кг в сутки в 4 введения. При неэффективности этой терапии переходят на цефоперазон с сульбактамом 75–160 мг/кг в сутки в 2–4 введения (в КР со знаком #, то есть вне инструкции).

4.4 Местная и симптоматическая терапия

Рекомендуется промывание полости носа изотонической стерильной морской водой или солевыми растворами. Слабые гипертонические растворы применяются только в остром периоде и не более 5–7 дней.

Назначение сосудосуживающих капель при остром синусите, согласно рекомендации, абсолютно необходимо, однако срок их применения ограничен **5–7 днями** из-за риска медикаментозного ринита. Нафазолин не применяется.

Детям до 6 лет применяются фенилэфрин 0,125%, оксиметазолин 0,01–0,025% и ксилометазолин 0,05% (с 2 лет).

Интраназальные глюкокортикостероиды применяют у пациентов старше 12 лет в монотерапии при затяжном поствирусном синусите или в сочетании с системными антибиотиками. Детям до 12 лет монотерапия глюкокортикостероидами допустима только при сопутствующем аллергическом рините.

Для монотерапии синусита без признаков бактериальной инфекции в России зарегистрирован только спрей мометазона.

Местные антибактериальные препараты используют в сочетании с системными или в монотерапии при лёгком синусите с признаками бактериального воспаления (гнойными выделениями). Эффективность оценивается через 3–4 дня.

Для лечения синусита зарегистрированы фрамицетин (детям с первых лет жизни) и комбинация дексаметазона, неомицина, полимиксина B и фенилэфрина (с 2,5 лет). Введение растворов антибиотиков для инъекций в полость носа и пазухи не допускается.

При лихорадке, головной и лицевой боли применяют нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Детям до 6 лет применяются только парацетамол (до 60 мг/кг в сутки) или ибупрофен (до 30 мг/кг в сутки), взрослым возможно назначение кетопрофена.

Возможно назначение мукоактивных препаратов, например ацетилцистеина или карбоцистеина. Перед назначением следует свериться с инструкцией, поскольку не все препараты разрешены при заболеваниях ЛОР-органов и в сочетании с антибиотиками.

Применяются растительные препараты с доказанным противовоспалительным и муколитическим действием: комбинации корня горечавки, цветков первоцвета, шалфея, цветков бузины и вербены, миртол, экстракт пеларгонии сидовидной.

Комбинированные препараты с парацетамолом без психотропных компонентов могут применяться для облегчения симптомов с 12 лет.

Системные антигистаминные препараты оправданы при сопутствующем аллергическом рините и в начальном периоде вирусной инфекции.

При вирусном синусите в комплексное лечение могут включаться противовирусные препараты, в том числе растительного происхождения.

При лёгком течении синусита в амбулаторных условиях возможно применение комплексных гомеопатических препаратов по зарегистрированным показаниям.

Бактериофаги рекомендованы взрослым с острым бактериальным синуситом; местное применение оправдано при устойчивости к антибиотикам или их непереносимости.

4.5 Хирургическое лечение

Пункция верхнечелюстной пазухи показана при рентгенологически подтверждённом наличии содержимого в пазухе и тяжёлом или среднетяжёлом течении без эффекта от системной антибактериальной терапии **в течение 5–7 дней**.

Детям пункция и трепанопункция выполняются только в условиях стационара; во многих случаях вместо них возможно применение синус-катетера.

Дренирование пазух, в том числе с помощью синус-катетера, выполняют при затяжном экссудативном синусите без обструкции соустий. При впервые возникшем неосложнённом синусите дренирование не показано.

При орбитальных или внутричерепных осложнениях показано хирургическое лечение в условиях стационара: вскрытие пазухи и дренирование абсцесса.

Иное лечение (раздел 3.3) и медицинская реабилитация (раздел 4) не требуются.

4.6 Профилактика

Детям из групп риска по респираторным заболеваниям рекомендованы местные и системные лизаты бактерий.

При рецидивирующем синусите и предрасполагающих к нему изменениях перегородки носа или латеральной стенки полости носа показано плановое хирургическое лечение.

4.7 Особые случаи

Сопутствующий аллергический ринит способствует затяжному течению синусита; в этом случае необходимы системные антигистаминные препараты и более высокая доза глюкокортикостероидов.

Лечение одонтогенного синусита хирургическое, с удалением пломбировочного материала и секвестров. Из антибактериальных препаратов предпочтительны респираторные фторхинолоны, поскольку преобладает анаэробная микрофлора.

---

5. Показания к госпитализации. Осложнения

разделы 1.5, 3 и 6 текста КР

Экстренная госпитализация в оториноларингологическое отделение показана:

1. при тяжёлом течении, в том числе с орбитальными и внутричерепными осложнениями;
2. при отсутствии улучшения на фоне системной антибактериальной терапии **в течение 3–5 дней**;
3. при прогрессирующем ухудшении состояния в любой момент.

Орбитальные и внутричерепные осложнения свидетельствуют о тяжёлом течении, острый средний отит о среднетяжёлом.

Пациента выписывают при стабильно удовлетворительном состоянии **в течение не менее 3 дней**.

---

6. Источник и актуальность

всегда полностью

Документ	Клинические рекомендации «Острый синусит»
Версия	3-я, год утверждения 2024, опубликована в рубрикаторе 28.10.2024
Статус	**Применяется** (карточка рубрикатора на 22.10.2026); год окончания действия не указан
Актуализация	По правилу из самой КР — «не реже чем один раз в три года» (прил. А2): следующая ожидается не позднее октября 2027

Код в рубрикаторе	313_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети
Целевая аудитория	Оториноларингологи, терапевты, педиатры

6.1 Исправления по результатам сверки с PDF

- Удалено предупреждение «пересмотр не позднее 2026»: в PDF и в карточке рубрикатора эта дата отсутствует, она была заимствована из пересказа MedElement.
- Доза амоксициллина у взрослых «500–1000 мг» заменена двумя дозами с условием: 500 мг при отсутствии факторов риска устойчивости пневмококка, 1000 мг при их наличии.
- Добавлены условия назначения амоксициллина с клавулановой кислотой и цефоперазона с сульбактамом, тиамфеникол для детей в стационаре, ограничение дозы цефуроксима «500 мг в сутки».
- Уточнены показания к пункции, ограничение для интраназальных глюкокортикостероидов у детей до 12 лет (монотерапия только при сопутствующем аллергическом рините), признаки степеней тяжести, критерии у детей («бесцветные или светлые выделения»).
- Удалена фраза «КТ рутинно не нужна», поскольку в КР она отсутствует.
- Добавлены разделы 5 «Профилактика» и 7 «Дополнительная информация».

6.2 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Детская доза амоксициллина: в тексте раздела 3.1 указано 50–60 мг/кг/сут, в таблице 5 указано 40–60 (80–90) мг/кг/сут.
- В таблице 5 для цефтриаксона указан код АТХ J01FA09, который является кодом кларитромицина; в тексте для цефтриаксона приведён верный код J01DD04.
- Знак # у ряда препаратов в этой КР не расшифрован. ⚠ В российских КР им, как правило, обозначается применение вне инструкции; это следует проверить по инструкции к препарату.

6.3 Шкалы доказательности

Шкала	Интерпретация
УУР А	Сильная рекомендация: все критерии эффективности являются важными, исследования высокого или удовлетворительного качества, выводы согласованы
УУР В	Условная рекомендация: не все критерии эффективности являются важными, не все исследования высокого качества и/или выводы не согласованы
УУР С	Слабая рекомендация: доказательства надлежащего качества отсутствуют
УДД 1–5	Для лечения: от 1 (систематический обзор рандомизированных контролируемых исследований с метаанализом) … до 5 (только обоснование механизма действия или мнение экспертов). Для диагностики используется отдельная шкала (табл. П1); точная расшифровка открывается при нажатии на бейдж